外科学 血管和泌外疾病

考频（0-3 题，★）：A_1 0-2　A_2 0-2　B 0-2　X 0-1

①周围血管疾病：动脉性疾病、静脉性疾病

②泌尿外科疾病：前列腺增生、肾结核、结石、肿瘤、外伤

核心精讲·周围血管疾病

（性感认识：动脉 VS 静脉性疾病）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一般:动脉和静脉性疾病很多积累于下肢(受重力影响),血管外科问题往往下肢多见

特殊:雷诺综合征,双侧手指多见

一、动脉性疾病

（一）雷诺综合征

①青壮年女性多见，多累及双侧手指（美甲）痉挛→缺血导致苍白发冷、缺氧导致代谢产物积聚青紫疼痛

②小动脉阵发痉挛→苍白发冷、青紫疼痛、潮红复原。动脉搏动正常、无杂音 中大A有问题,才会有杂音,小A能量不够

③治疗：肾上腺素能神经末梢阻断剂如胍乙啶、利血平（瓜瓜一定摆平）。禁用普萘洛尔 阻断血管平滑肌β2-R加重平滑肌痉挛

雷诺现象可见于：雷诺病、系统性硬化症、SLE（抗 RNP 抗体）、多发性骨髓瘤

指指引雷boom　混混人品被高空雷击　部分M蛋白为冷球蛋白

2234都积极笑,变异咯

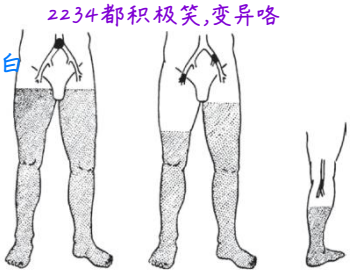


图 34-1　不同位置动脉栓塞后皮肤温度的改变
阴影代表皮肤温度降低区，都较实际栓塞部位低。

（二）急性动脉栓塞

①左心来源的栓子最常见 e.g 房颤、感染性动脉炎、扩心病、心梗

②5P 综合征：疼痛、麻痹、苍白、无脉、感觉异常（痛骂白无常）

③治疗：创伤少 **急诊 Fogarty 球囊导管取栓**、或**切开动脉直接取栓**

若不耐受手术、**坏死**、远端小动脉栓塞、或栓塞时间长有侧枝→**溶栓**

小范围　导管无法介入，靠药物弥散　血栓栓子与肉芽组织发生机化,与血管壁粘连

（三）动脉硬化闭塞症 VS 血栓闭塞性脉管炎/Buerger 病

中大动脉　中小动静脉

1.共性

①表现：疼痛、麻木、苍白、寒冷、动脉搏动减弱消失 VS雷诺综合征小动脉痉挛不会导致动脉搏动减弱消失

②治疗：VS冠心病:经皮冠脉成形术PTCA **经皮腔内血管成形术**（PTA）、旁路转流术，下垂患肢、保暖但不加热、抗板、抗凝、扩管等 加热增加耗氧　补液or血管扩张剂

③分期（一麻二跛三静四坏） 肱动脉是上肢血流,上肢血流比较稳定

I	仅麻木寒冷、动脉搏动减弱、踝/肱指数 ABI＜0.9（酒干吗） 正常情况ABI应该>某个值,因为重力原因,踝部动脉压力要比肱动脉压力大
II	间歇性跛行（IIa＞200m/IIb＜200m）、动脉搏动消失（II-200）
III	静息痛、夜间痛
IV	坏疽发黑、ABI＜0.4（IV-0.4）

走一会停一下

④病情严重程度可用 Rutherford 分级 ttsx

间歇性跛行

1 级：轻度间歇性跛行、最大跛行距离＞500m

2 级：中度间歇性跛行、最大跛行距离 300-500m（2+3=5）

3 级：重度间歇性跛行、最大跛行距离＜300m 3-300

4 级：静息痛、夜间痛（静夜思）

5 级：少量组织缺损或活动性溃疡

6 级：大面积组织溃疡或坏疽